

Campaña de sensibilización para difundir el protocolo de atención sanitaria

Personas con autismo en la Sanidad Pública Andaluza

FEDERACIÓN Autismo Andalucía

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

GUIÓN

1. PROBLEMAS DE SALUD EN TEA
2. ENTORNOS SANITARIOS
3. PROTOCOLO DE SALUD
4. CAMPAÑA DIFUSIÓN
5. BIBLIOGRAFÍA



EL TEA Y LA SALUD

Un punto de partida …

CVRS:
Calidad de vida relacionada con la salud

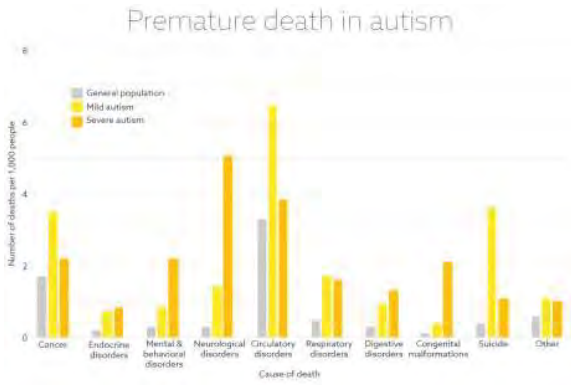
- Los adultos con TEA **tienen menor CVRS física y mental que sus iguales** en la población general adulta de Estados Unidos. Los **adultos jóvenes** con TEA (18-24 y 25-34 años) tenían un **menor CVRS física** que sus iguales en la población general.
- Factores con influencia significativa en la CVRS (y potencialmente modificables): **Apoyo social de la familia y amigos** y **Estrategias desadaptativas de afrontamiento** que tienen.
  - **Redes de apoyo:** Puede que estos adultos perciban el apoyo recibido de amigos como uno de los indicadores del éxito de su integración en la sociedad, lo que añade un sentido de propósito en su vida diaria. Para muchas personas con TEA, **las relaciones sociales son generalmente difíciles de desarrollar**. Sin embargo, una vez que se desarrollan, **les dan un alto valor a las mismas**, más que un adulto sin TEA para quienes son más fáciles de lograr.
  - **Estrategias afrontamiento: relación entre conductas de afrontamiento inapropiadas y la CVRS**. (Abbott, Hart, Morton, Gee, & Conway, 2008; Hedlund, Ronne-Engström, Carlsson, & Ekselius, 2010; Klein, Turvey, & Pies, 2007). Dada la naturaleza crónica de los TEA, es esencial que estas personas sean conscientes de los **efectos negativos para la salud asociados al uso de estrategias desadaptativas de afrontamiento como sentimiento de culpa, negación** o el **desfogue**. Estrategias como el **humor, la reformulación positiva, y el uso de apoyo emocional** pueden tener efectos beneficiosos a largo plazo.

Khanna, R., Jariwala-Parikh, K., West-Strum, D., & Mahabaleshwarkar, R. (2014). Health-related quality of life and its determinants among adults with autism. *Research in Autism Spectrum Disorders*, *8*(3), 157-167.

Mortalidad prematura en personas con autismo

Sospecha generalizada de que las personas con TEA tienen menor esperanza de vida (< grave DI).

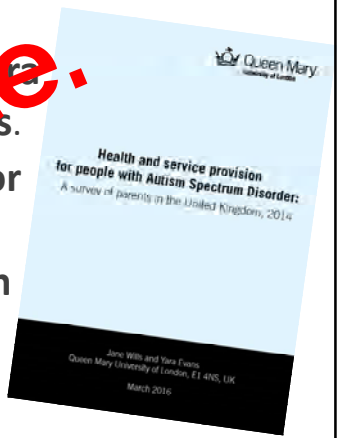
- Mueren, de media 18 años antes que la población general.
- Si además DI, mueren, una media de 30 años antes que normotípicos similares.
- **Las personas que viven en grandes instituciones < esperanza de vida**: Causa principal de muerte insuficiencia respiratoria (50%), crecimiento tasas cáncer gastrointestinal (Carter y Jancar, 1983).
- ↑ prevalencia de demencia.



Mortalidad prematura en personas con autismo

- Riesgo muerte prematura **2,5 veces mayor**.
- **2ª factor mayor mortalidad, familias dificultades para conseguir buen servicio sanitario para sus hijos**.
- Los adultos **SA riesgo 9 veces mayor de morir por suicidio**, > en mujeres; soledad y depresión.
- Frecuencia de suicidios **menor en las personas con TEA y DI**.

Reto imprescindible.



www.thinkingautism.org.uk/taking-action/resources-and-publications/health-and-service-provision-for-people-with-autism/ /

1. Problemas de salud de las personas con TEA

1. Problemas de salud de las personas con TEA

A Problemas de salud

B Problemas asociados

C Dificultades

A. PROBLEMAS DE SALUD

MÁS PROBLEMAS DE SALUD QUE EL RESTO DE LA POBLACION Y ADEMÁS:

CI < 70

- Dificultades para cooperar en la consulta médica. Para comunicar dolor. Mutismo.
- Dificultades para consentir tratamiento, seguir instrucciones, toma de medicación.
- Reacciones de miedo ante personal sanitario.

CI >70

- Problemas de expresión de síntomas (hacerse entender), parecer desagradables o maleducados, "formalismos y tecnicismos". Contar su problema fuera del contexto. Alteraciones sensoriales.
- Dificultad para entender reglas, demandas y expectativas de entornos y profesionales sanitarios.
- Problemas lenguaje literal o incomprensión de exploraciones físicas "tocamientos" .

¿QUÉ PROBLEMAS DE SALUD TIENEN LAS PERSONAS CON AUTISMO? (I)

- Las personas con autismo **tienen más posibilidades de ponerse enfermos** e incluso morir por un problema de salud que el resto de la sociedad.
- Las personas con autismo suelen tener problemas de salud como:
  - **EPILEPSIA**: en las personas con TEA, el porcentaje asciende al 30-50%.
  - **ALTERACIONES DEL SUEÑO**: La prevalencia de trastornos del sueño en niños con autismo es de 44-83%.
  - **PROBLEMAS GASTROINTESTINALES**: Entre un 46-85% de las personas con TEA padecen problemas gastrointestinales, como el estreñimiento crónico o la diarrea.
  - **PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS**: Más del 12 % en niños/as con autismo.
  - **OTRAS DIFICULTADES ASOCIADAS**: síndrome premenstrual, infecciones óticas, oftalmológicos, lesiones dérmicas, alteraciones del movimiento, problemas nutricionales…
  - **OTRAS ENFERMEDADES:** Cáncer**,** neurofibromatosis, esclerosis tuberosa,etc.

A. PROBLEMAS DE SALUD

EPILEPSIA:

- Se presenta en personas con TEA con **mayor frecuencia** que en la población general (30-50%) en la vida adulta.
- **Crisis de ausencia** pueden pasar desapercibidas, por dificultades en la comunicación.
- Algunos casos descritos (Diez Cuervo et al., 1987) se encuentran casos de **epilepsia oculta** cuyas manifestaciones críticas son interpretadas como agudización de la conducta peculiar.
- Tto. con **medicación antiepiléptica** según el tipo y la frecuencia, siempre basadas en las necesidades individuales. Prescrita por especialista.

A. PROBLEMAS DE SALUD

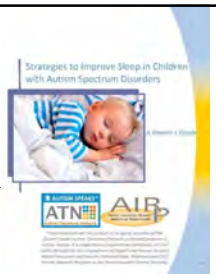
https://www.youtube.com/watch?v=scgwMR6x_5U

EPILEPSIA

¿Cómo actuar ante un ataque epiléptico?

- TUMBAR EN EL SUELO, ayudándole a caer suavemente. NO respiración boca a boca (SÓLO SI PASAN + DE 2 MIN respiración artificial).
- NO TRATAR DE CORTAR ATAQUE, NO ABRIRLE LA BOCA NI INTRODUCIRLE LOS DEDOS EN LA BOCA.
- PUEDE SER ÚTIL COLOCAR objeto blando entre los dientes (para evitar mordeduras de la lengua). CUIDADO CON RIEGO DE ASFIXIA POR ATRAGANTAMIENTO.
- Evitar que se autolesione, DESPEJANDO LA ZONA DE OBJETOS PELIGROSOS.
- Aflojarle la ropa, SOBRE TODO ALREDEDOR DEL CUELLO Y LA CINTURA. Colocarle una ALMOHADA O ROPA DEBAJO DE LA CABEZA para evitar que se golpee contra el suelo.
- LADEAR LA CABEZA. COLOCARLE EN LA POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD cuando haya pasado la crisis y controlar constantes vitales. La convulsión debería acabar en un corto periodo de tiempo, aunque puede llegar a repetirse. Puede que no recuerde nada y se encuentre aturdido tras el ataque.
- TRASLADAR AL HOSPITAL O PEDIR AYUDA ESPECIALIZADA.

A. PROBLEMAS DE SALUD



ALTERACIONES DEL SUEÑO

- Problema asociado **MUY** frecuente (70 % de los casos).
- Incluyen dificultades en conciliación del sueño, despertares nocturnos o repentinos o más temprano de lo habitual.
- **CAUSAS**: reflejo de un desorden subyacente orgánico, naturaleza conductual (debido a algún estímulo / los + afectados: no distinción noche y día /miedo a la oscuridad / a quedarse solos…), o una combinación de ambos.
- No solo afecta el estado de salud de la **persona** sino también a su **entorno**.
- **INTERVENCIÓN**: Estrategias conductuales para asegurarnos una adecuada higiene del sueño (Comprobar no hambre ni sed y no saber pedirlo, dar acceso a revistas o juguetes de su interés, rutinas…) e intervención médica en aquellos casos con causas orgánicas con pruebas y medicación oportunas.

A. PROBLEMAS DE SALUD



PROBLEMAS GASTROINTESTINALES

- Son frecuente casos que muestran una **variedad limitada de preferencias** de alimentos / **intolerancia absoluta** a algunos de ellos.
- **CAUSAS**: rechazo a la transición entre texturas, alimentos de un color particular, mayor sensibilidad o dificultades con la hora de comer.
- Estas preferencias alimenticias pueden ser **reflejo de rigidez conductual.**
- Son frecuentes **rituales** en comidas (siempre = sitio, muy despacio, muy rápido, sin masticar, normas educación - escupir, rigidez horaria, etc.), beber compulsivamente o no hacerlo, etc.
- Otros hábitos de riesgo: regurgitaciones, atragantamientos, pica (ingesta de sustancias no comestibles) coprofagia o sintomatología obsesivo-compulsiva con rituales alimenticios, etc… **REMITIR A ESPECIALISTA** con experiencia en trastornos de alimentación en esta población. No muy frecuentes casos de desnutrición o malnutrición.

Comer: una guía para todos los públicos



ROSA VENTOSO
NATIONAL AUTISTIC SOCIETY

Problemas de alimentación



- Hiperselectividad alimenticia.
- Problemas con la masticación.
- Asociación de la comida a momentos de enfado.
- Texturas.
- Nuevos sabores.
- Colores.
- Velocidad.
- Regurgitaciones.
- Inflexibilidad ante cambios.
- Dolor físico e incomodidad.
- Obsesiones, intereses especiales y rutinas.

Cuándo intervenir

No preocuparse demasiado si la persona está comiendo alimentos de cada uno de los principales grupos de alimentos y está creciendo bien (si es un niño). Buscar ayuda si:

- Acepta **menos de 20** alimentos.
- **Rechaza todos** los alimentos **de uno o más grupos** de alimentos.
- Está **estreñido**: el estreñimiento puede tener un gran impacto en el apetito y puede requerir medicación.
- Sufre de **caries** como resultado de su dieta.
- **Pierde peso** o **no crece** bien.
- **Gana peso** excesivamente.
- Muestra, por ejemplo, **cansancio o pica** que podrían indicar deficiencia de vitaminas o minerales (Ej. anemia por deficiencia de hierro).
- **Falta a la escuela** debido a problemas de alimentación.
- Tiene **tos o se atraganta mientras come**, o tiene **infecciones recurrentes en el pecho**, especialmente si tienen retraso en el desarrollo o discapacidades físicas **Pierde oportunidades sociales**, ej. si ellos y su familia rara vez pueden salir debido a los problemas de alimentación.

Encontrar la Causa

Registrar qué come y cuándo. A veces, un registro de alimentos puede sorprendernos al ver que la persona come una variedad más amplia de alimentos de lo que se pensaba. Ej.



1. ¿A qué hora del día come? - 11.05
2. ¿Qué come? - Patatas fritas con sal y vinagre
3. ¿Donde come? - En la sala de estar
4. ¿Cuánto come? - Dos bolsas
5. ¿Quien estaba ahí? - mamá, hermano
6. ¿Cómo respondió la gente a la persona que estaba comiendo ese alimento en particular? - Mamá elogió, hermano no tuvo reacción.
7. ¿Había factores ambientales? - La radio estaba encendida de fondo.

Tratar de averiguar si el problema principal es la **cantidad**, el **tipo o la variedad** de alimentos que se ingieren, y luego **qué problemas subyacentes**, o **aspectos sensoriales**, pueden estar involucrados.

Problemas de alimentación



Consideraciones generales (Rosa Ventoso):

- Las comidas son momentos agradables.
- En la hora de comer, sólo se come; no se juega ni se ve la TV.
- La comida es algo "rico y apetecible".
- La comida constituye un ritual cuya forma la va a marcar el adulto.
- Nunca se va a entrar a "luchar", ni a forzarle más de lo "imprescindible".
- Todos los días hay que comer, y hay que comer una cantidad previamente establecida (plato vacío)

Resumiendo…



Pautas de actuación:

- Crear una **rutina** y mantener **constantes las condiciones físicas** (sin distractores ni ruidos)
- **Premiar al final** con situación agradable.
- Elegir una **situación nueva** para ofrecer alimentos nuevos sólidos que le atraigan. **Generalizarlo** a otras comidas alternándolo con otros que no le gusten.
- **Ir aumentando la textura** de forma lenta y progresiva.
- **Ir invirtiendo la cantidad** de alimentos placenteros/ displacenteros.



- **Información visual** anticipada. Una historia social podría ayudar a alguien a entender por qué comemos y la función de los alimentos.
- Incorporar progresivamente sabores agradables/ nuevos, texturas progresivamente más espesas… Exigencia inicial baja (cantidad) y postre muy apetecible.
- No manchar, no forzar, no mezclar.
- **Temperatura** adecuada.
- Ofrecer **agua**.
- No perder la paciencia, no chillar, no perder la sonrisa. Siempre dar muestras de **serenidad y FIRMEZA**.

Que NO hacer



- **Forzar con restricción física**, le embadurnamos y no traga nada.
- **Introducir sólido directamente y en todas situaciones** (si no puede comer otra cosa, algún día comerá: Cuidado problemas de nutrición).
- **Evitar usar un alimento preferido** como **recompensa** por probar un alimento nuevo o no preferido
- **Manipularle mejillas** para que las mueva y mastique.
- Dejarle con el plato de comida "**castigado**" hasta la siguiente hora.
- **Porciones grandes** para que acabe antes, sin cuidar que trague.
- Dejarle con "**bola**" del alimento en la boca y no permitir que escupa (mejor dejarle y ofrecer trocito más pequeño y fácil de tragar)
- **Hablar continuamente**, recriminándole.
- y el más complicado de controlar: **perder la paciencia y la calma.**

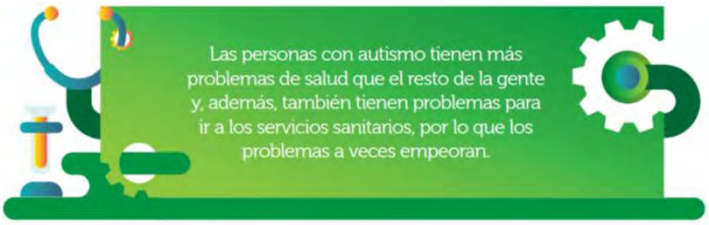
A. PROBLEMAS DE SALUD

ENFERMEDADES O TRASTORNOS ASOCIADOS:

- Algunos con mayor frecuencia (fragilidad X, esclerosis tuberosa, Angelman, Prader-Willi, Down,…).
- **En mujeres**: síndrome premenstrual (cambios de humor, fatiga, irritabilidad,etc), problemas hormonales como hirsutismo (crecimiento excesivo de vello), síndrome de ovario poliquístico, dismenorrea (períodos dolorosos), alteraciones en el ciclo menstrual y acné).
- **Infecciones óticas**.
- **Problemas oftalmológicos**: + errores de refracción (Dificultad para ver con claridad) y estrabismo (los ojos no se alinean en la misma dirección). Dificultades movimientos oculares.
- **Lesiones dérmicas** como eccemas, lesiones de rascado o secundarias a comportamientos autolesivos.

¿QUÉ OTROS PROBLEMAS ASOCIADOS TIENEN LAS PERSONAS CON AUTISMO? (II)

- Las personas con autismo suelen tener problemas de salud como:
  - **SALUD MENTAL**: Infradiagnosticados, pero los + frecuentes: trastorno por **ansiedad** social (29.2%), trastorno por **déficit de atención e hiperactividad** (28.1%), trastorno **oposicionista-desafiante** (28.1%) trastorno por **ansiedad generalizada** (13.4%), trastorno de **pánico** (10.1%) y **enuresis** (11%). Además, 10,9% periodo significativo de **depresión o irritabilidad** que no cumplía criterios DSM-IV de trastorno depresivo o distímico (Simonoff et al., 2008).



B. PROBLEMAS ASOCIADOS

HIPERACTIVIDAD:

- Las dificultades de atención a ciertos aspectos del ambiente son características de niños con TEA.
- Manifestaciones: pobre discriminación, enfocar estímulos insólitos o parciales y cambios rápidos de foco de atención que pueden ir asociados a un aumento general de la actividad.
- Algunos manifiestan más síntomas hiperactivos que otros y a veces pueden responder a los mismos tratamientos que (TDA/H) en la población general (especialista).

B. PROBLEMAS ASOCIADOS

Trastornos Psiquiátricos: psicopatología asociada o secundaria. Difícil diagnóstico por solapamiento y dificultades comunicativas.

- **Ansiedad**: **+ Común**. Causas: evitación contacto social, interferencias con rituales o por aversiones específicas (miedos/fobias). Limitan participación. Tratamiento conductual y/o farmacológico
- **TOC**: Causas: intereses limitados o estereotipias. La excitación suele acompañar al comportamiento ritualista ➔ intentos distractorios = reacciones explosivas o agresiones. Tratamiento conductual y/o farmacológico.
- **Depresión:** Causas diferentes y síntomas distintos: < tiempo de sueño, > nivel de actividad, agresión no provocada, desinhibición (p. ej., sexual), > apetito , irritabilidad, y vértigo o alegría, sobre todo si son cíclicos= posible trastorno bipolar. A veces la pista principal es la periodicidad de cualquier conducta (como agresión, etc.), a menudo precedida de insomnio inusual. Si sospecha = especialista para evaluación y tratamiento.

Centrarse en la salud mental

Los problemas emocionales y de conducta empiezan en la infancia

Hasta un 70% de niños/as en edad escolar tienen niveles clínicos de psicopatología:

- Ansiedad, especialmente ansiedad social.
- Conductas disruptivas/antisociales; TDAH.
- Aislamiento social, ensimismamiento.
- TOC.
- Fobias.



Brereton et al.(2006)
Leyfer et al., (2006)
Simonoff et al.(2008)
van Steensel et al. (2011)

P. Howlin

En la etapa adulta: los problemas de salud mental aumentan

Incremento en diagnósticos de salud mental con la edad:

- **EE.UU.**: el 42% de los adolescentes; 51% de adultos.
- **Reino Unido**: 22% desarrolla nuevos problemas psiquiátricos (principalmente en la adolescencia tardía / adultez temprana).
- **Aumento en el uso de medicamentos** a lo largo del tiempo.

  Estudio en EE.UU.:
  - el 64% de los adolescentes; 88% de los adultos con al menos un medicamento,
  - 18% de los adolescentes, 49% de los adultos con 3 o más medicamentos.

(Seltzer et al., 2009; 2010; Howlin et al., 2004; Hutton et al., 2009)



¿Tasas de problemas de salud mental en TEA?

- Las estimaciones de los principales trastornos psiquiátricos varían ampliamente:
  - > 75%: *Joshi et al. 2013; Gillberg et al., 2016; Gotham et al., 2015; Lever & Geurts 2015*
  - *60-70% Buck et al., 2014; Roy et al., 2015*
  - *40-60% Moss et al., 2015; Russell et al., 2016*



(Reviews: Davis et al., 2011; Levy and Perry, 2011; Mannion et al., 2014; Mazzone et al., 2012; Moss et al., 2016)

Mejor acuerdo sobre los *tipos* de problemas de salud mental

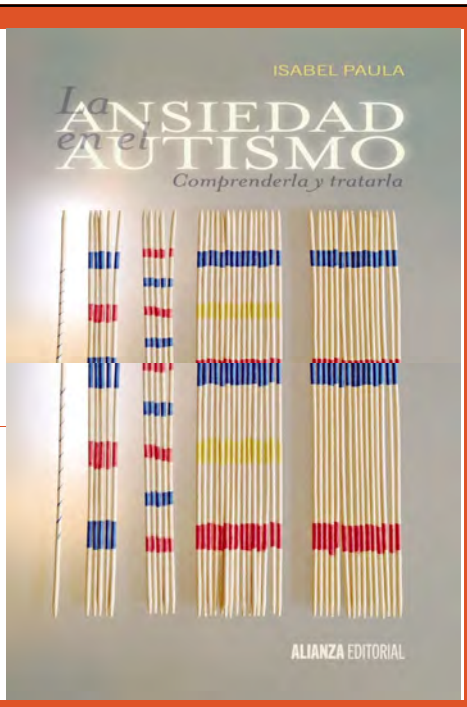
- Más comunes: trastornos **depresivos** y relacionados con la **ansiedad** (incluidas fobias y trastorno obsesivo-compulsivo); **TDAH**…
- Tasas **relativamente bajas de esquizofrenia/psicosis** severa.
- Pero los rangos informados varían ampliamente.
  - Ansiedad 42% - 56%.
  - Depresión 17% - 70%;
  - Trastorno bipolar 8% - 27%
  - Síntomas del TDAH 28% - 65%



(Joshi et al. 2013; Gillberg et al., 2016; Gotham et al., 2015; Lever & Geurts 2015; Buck et al., 2014; Roy et al., 2015; Moss et al., 2015; Russell et al., 2016)

***Varios estudio indican éxito de las Técnicas básicas de Terapia Cognitivo Conductual**

Ansiedad

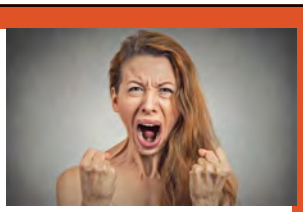


Prevalencia de la ansiedad en los TEA

- Problema: No instrumentos específicos.
- Metaanálisis más amplios: existe ansiedad **clínicamente significativa entre el 11% y el 84% población TEA** (MacNeil, Lopes y Minnes, 2009; White. Oswald. Ollendick y Scahill, 2009: Van Steensell, Bögels y Perrin, 2011).
- Ansiedad en adultos sin autismo: 18% (Kessler, Chiu, Demler y Walters. 2005), y en niños sin autismo en 15% (Beesdo, Knappe *y* Pine, 2009).
- La prevalencia de **la ansiedad en el autismo es sustancialmente más alta** que en la población general.



Crisis nerviosas



- Cuando la ansiedad colapsa a la persona, **crisis nerviosas**:

reacciones catastróficas. **Respuesta de adaptación instintiva** a los estresores que abruman a la persona. No responden a llamadas de atención ni se planifican o provocan a propósito. Son **respuestas involuntarias, explosivas e inconscientes**, intentar corregirlas mientras se suceden solo conducirá al fracaso. La única manera de **minimizarlas y tratarlas** sería a través de estrategias "precrisis", preventivas. La respuesta ha de ser **proactiva y no reactiva**.

- Una vez desatada la crisis, es conveniente **dar a la persona** con autismo el **tiempo necesario para purgar y liberar la tensión y la ansiedad**. Después la persona se sentirá como renovada. Las evidencias apuntan a que las crisis tienen una función reconstituyente y regeneradora, ya que una vez recuperada, **la persona parece sentirse lo suficientemente mejor como para seguir funcionando**.
- **No confundir con rabietas**, porque podemos empeorarlas. Las rabietas son comportamientos manifestados a propósito, voluntarios, realizados para conseguir un determinado resultado. En una rabieta, la conciencia es plena y no responde a apagón cognitivo.

Intervención, 3 niveles:



1. **Entorno autistic friendly:** Adaptación de tareas, los estímulos, la metodología de aprendizaje, el mobiliario, el espacio, el tiempo, a una mente que percibe la información, la procesa *y* funciona de manera diferente.
2. **Enseñar a la persona HH de regulación emocional.** La persona con TEA como agente activo que ha de aprender nuevas maneras de hacer, nuevos recursos, nuevas pautas de conducta…
3. Que hacer **cuando la la crisis nerviosa se ha desencadenado,** cuando la ansiedad ya ha desbordado a la persona y todo estalla en pedazos.

Ingredientes de un plan de gestión de estrés



Una **buena evaluación**:

- Identificar sus signos de estrés.
- Identificar sus elementos generadores de estrés.
- Ver qué estrategias de afrontamiento tiene.

Estrategias de gestión de estrés:

- Reducir los elementos generadores de estrés: entorno adaptado al autismo.
- Ayudarles a afrontarlo: enseñar resiliencia para el estrés.

Autolesión y TEA



Autolesión y TEA



Algunas de las particularidades que caracterizan la autolesión en el autismo son:

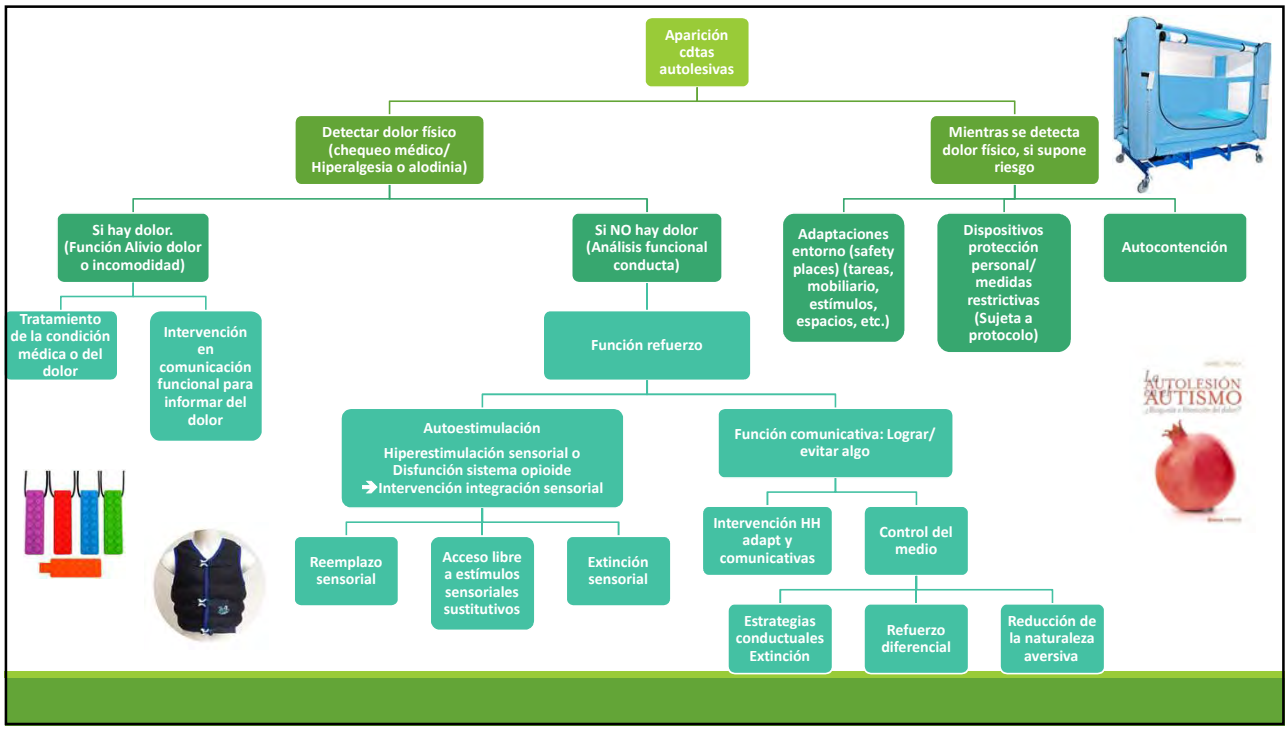
a) Daño físico a tejidos corporales (moratones, arañazos, mordeduras, usualmente en cara, cabeza y extremidades) frente al envenenamiento, quemaduras o cortes.
b) Se basa en un movimiento rítmico, repetitivo y constante con el que pueden provocarse varios golpes por minuto; ej golpearse en la cabeza una y otra vez.
c) La autolesión no está predeterminada, la persona no la idea ni la planifica.
d) Puede producirse una explosión después de largos períodos sin autolesiones.
e) A menudo se llevan a cabo en aparente ausencia de dolor.
f) Más probable a mayor discapacidad intelectual o severidad del TEA.
g) La frustración, la ansiedad y el deseo de escapar de una situación pueden formar parte de los motivos que desencadenan la autolesión.

Autolesión y TEA



La topografía de la autolesión en el autismo es heterogénea. Las más comunes son:

- **Golpearse la cabeza**: una de las más comunes. Puede ser un indicador de dolor de cabeza o migraña y debe descartarse el problema médico.
- **Frotarse o rascarse la piel:** las causas pueden ser múltiples; ej. sequedad de la piel, intolerancia a alimentos, efectos secundarios a medicamentos, necesidad de autoestimular con dolor los músculos o los huesos debido a insensibilidad al dolor o a pobre sensación propioceptiva.
- **Darse golpes o infligirse daño en los ojos *(eye-pocking):*** más del 20% de pacientes con un diagnóstico de autismo puede tener hipocalciuria7, casi siempre sin hipocalemia8 (Coleman, 1994).
- **Arrancarse el pelo** desde el cuero cabelludo, las pestañas, las cejas y el vello púbico (tricotilomanía) (Hamdan-Allen, 1991; Ghaziuddin, 1991; Holttum, 1994; Kurita, 1994).



C. DIFICULTADES

ALTERACIONES SENSORIALES:

- **Diferente umbral** de dolor.
- **Respuestas idiosincráticas** a los estímulos.
- **Hipersensibilidad:** Sentir y procesar los estímulos con **más intensidad**.
- **Hiposensibilidad: Falta de reacción** ante un estímulo sensorial como puede ser un sonido, un olor, un dolor… O bien la **búsqueda de sensación** para que la información sea procesada por el cerebro por ejemplo pueden tener una necesidad constante de tocar a las personas o texturas, incluso cuando no es socialmente aceptable.
- **Dispraxia** (Torpeza motora) (S. Asperger) = dificultan o enlentecen acciones de respuesta a estímulos o situaciones de riesgo.
- **Sinestesia**: (poco común) experimentar sensaciones de una modalidad sensorial a partir de estímulos de otra distinta (Por ejemplo, ver colores cuando se escuchan sonidos).
- Problemas para procesar información sensorial: inadecuada/lenta respuesta a peligros.
- **Presencia de hábitos sensoriales inusuales o fobias** (inhalación sustancias, manipulación heces, …)

C. OTRAS DIFICULTADES

- Problemas de **comprensión del sentido del peligro, en su forma de procesar la información o dificultad de planificar una acción =** cierta tendencia a ser victimas de accidentes.
- **Reacciones particulares a ciertas sensaciones**: Frío= no abrigo, no cubrirse de la lluvia, apretarse en exceso una prenda de vestir, etc.
- **Rituales o autoagresiones =** Daño físico.
- **Pensamiento inflexible o rígido** y/o Respuestas inadecuadas al contacto físico ("asaltante"): Peleas.
- **La honestidad y la falta de dobles intenciones =** Fáciles victimas de situaciones de **abuso** psicológico, sexual o físico.
- **Condicionamiento aprendido** a entornos sanitarios.

2. Entornos sanitarios

Características que influyen en el acceso a recursos sanitarios (1)

- Poca o nula tolerancia a las **situaciones de espera** y manejo de **conceptos abstractos** como el tiempo.
- **Dificultades de comunicación verbal o no verbal**, complicaciones atención médica: historia clínica, diagnóstico de enfermedad o ajuste de medicación.
- Un alto porcentaje tiene **discapacidad intelectual** (50-70%) o no tiene lenguaje oral.
- Necesidad de **interpretación de los familiares/cuidadores** para reconocer sintomatología.
- Comorbilidad alta con **trastornos psiquiátricos**.
- **Dificultades para identificar estados físicos o emocionales**, para localizar el origen del dolor y expresar al personal sanitario su malestar, la intensidad de los síntomas o el tiempo transcurrido desde su aparición.

Características que influyen en el acceso a recursos sanitarios (2)

- Dificultades **salir entorno habitual** y reacciones conductuales negativas ante **cambios de rutina**.
- Conductas **repetitivas**, intereses **restringidos** e **inflexibilidad** complican exploración médica
- Conductas **autolesivas** (morderse, rozarse, darse cabezazos, etc.) ante situación de disconfort por limitadas estrategias afrontamiento.
- Gran **dependencia en el cuidado personal**, dificultad en el desarrollo de hábitos saludables: nutrición, ejercicio físico, higiene bucal, sueño u otros.
- Frecuente **polimedicación** y efectos **paradójicos** de los tratamientos farmacológicos.
- Frecuente **ansiedad**, e incluso **fobias**, a someterse a determinadas pruebas y exploraciones médicas basadas en anteriores episodios desagradables.
- Frecuentes **alteraciones sensoriales**.

2. Entornos sanitarios

- A — Entornos sanitarios amigables
- B — Pistas, ideas...
- C — ¿Cuándo acudir?
- D — Atención primaria
- E — El hospital

Entornos sanitarios amigables.



ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS



- **No existe política de atención** a personas con TEA.
- Falta de **conocimiento del personal sanitario** de los TEA.
- **Riesgos**: Ser incomprendido, necesidades malinterpretadas, diagnósticos erróneos por problemas de comunicación …
- En el mejor de los casos se conoce el **extremo más afectado** del espectro. "**Discapacidad invisible**".
- **Familias o personas con TEA**: no comunicar diagnóstico.
- Dificultades de **solapamiento de diagnóstico**.
- Elevado riesgo de **suicidios**.

IDEAS ÚTILES

Presentación para profesionales sanitarios



Plan de Atención a los Pacientes con TEA

El objetivo del plan es mejorar la atención sanitaria a las personas con TEA en Andalucía.

https://www.picuida.es/protocolo-para-mejorar-la-accesibilidad-de-las-personas-con-trastorno-del-espectro-autista-tea-al-sistema-sanitario-publico-de-andalucia/

En 2018 se publicó la primera versión del protocolo y en 2019, le acompañaron 2 vídeos de sensibilización:

https://www.youtube.com/watch?v=6mVn1TLkWNY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dcdu3d-364g&t=1s



Nuevas versiones, en 2019



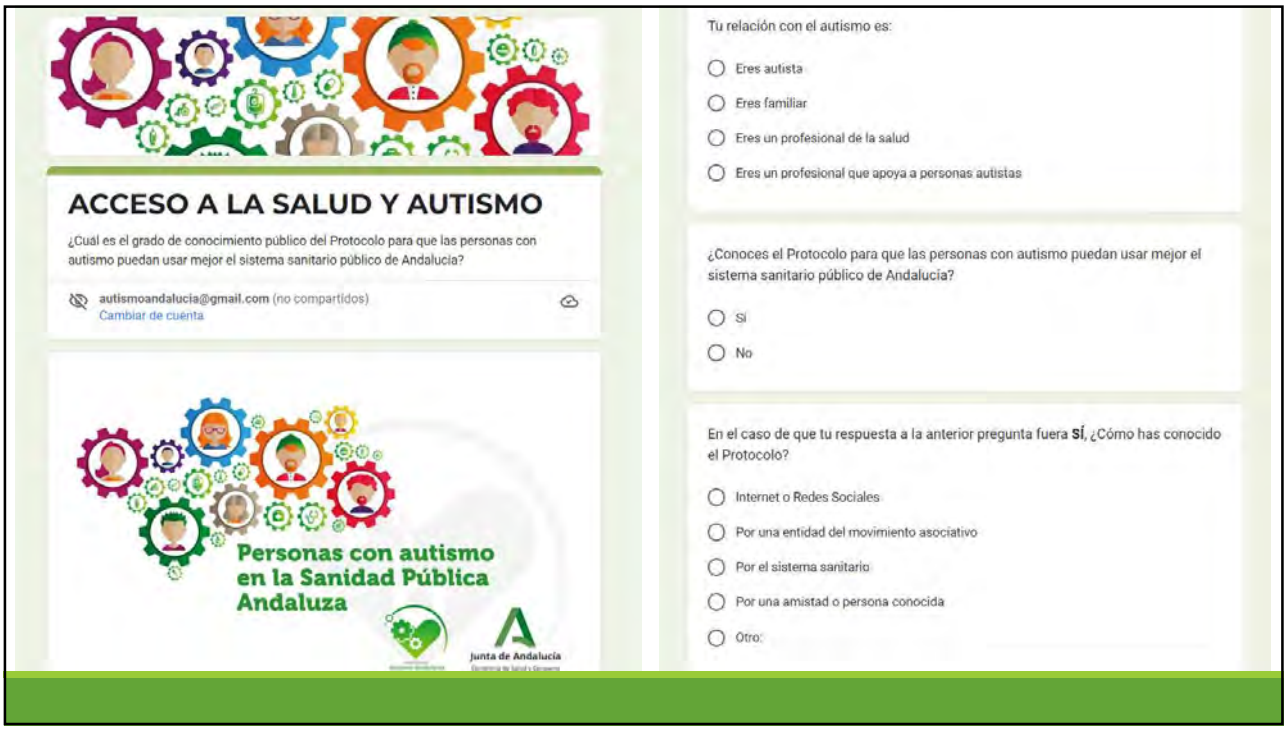


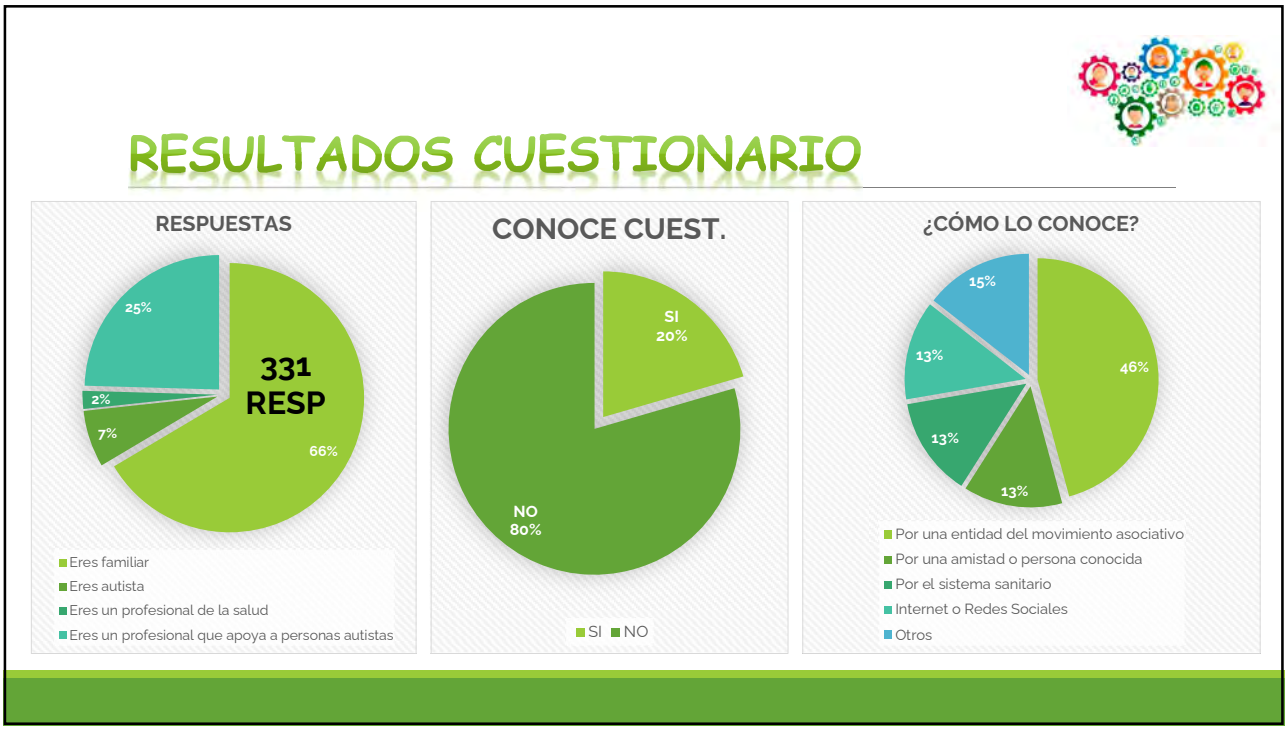
Personas con autismo en la Sanidad Pública Andaluza

SITUACIÓN ACTUAL CUESTIONARIO

FEDERACIÓN Autismo Andalucía

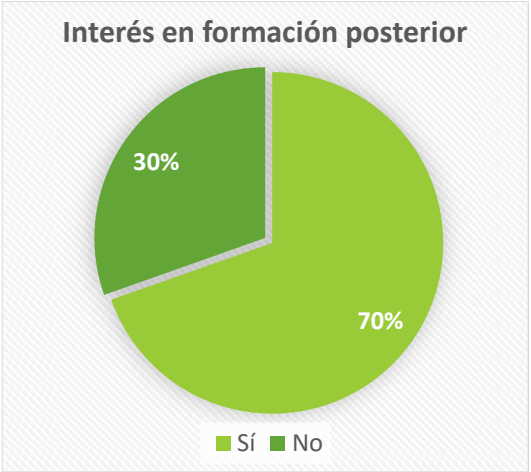
Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo


ACCESO A LA SALUD Y AUTISMO
¿Cuál es el grado de conocimiento público del Protocolo para que las personas con autismo puedan usar mejor el sistema sanitario público de Andalucía?
autismoandalucia@gmail.com (no compartidos)
Cambiar de cuenta
Personas con autismo en la Sanidad Pública Andaluza
Junta de Andalucía
Tu relación con el autismo es:
Eres autista
Eres familiar
Eres un profesional de la salud
Eres un profesional que apoya a personas autistas
¿Conoces el Protocolo para que las personas con autismo puedan usar mejor el sistema sanitario público de Andalucía?
Sí
No
En el caso de que tu respuesta a la anterior pregunta fuera SÍ, ¿Cómo has conocido el Protocolo?
Internet o Redes Sociales
Por una entidad del movimiento asociativo
Por el sistema sanitario
Por una amistad o persona conocida
Otro:


RESULTADOS CUESTIONARIO
RESPUESTAS
331 RESP
25%
2%
7%
66%
Eres familiar
Eres autista
Eres un profesional de la salud
Eres un profesional que apoya a personas autistas
CONOCE CUEST.
SI 20%
NO 80%
SI
NO
¿CÓMO LO CONOCE?
15%
46%
13%
13%
13%
Por una entidad del movimiento asociativo
Por una amistad o persona conocida
Por el sistema sanitario
Internet o Redes Sociales
Otros

RESULTADOS CUESTIONARIO

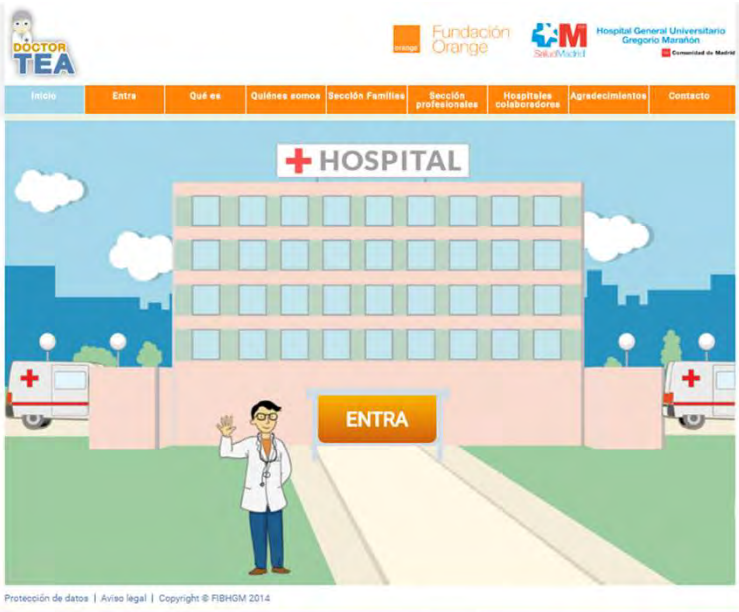




+ IDEAS ÚTILES

- Reconocer expertez de las familias (traductores).
- Conocer a la persona y preparación previa.
- Kit de recursos personalizados: Libro de comunicación, apoyos hipersensibilidad…
- Formación al personal sanitario…





ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS

- Como la población en general, esta atención sanitaria debe tener lugar en la **comunidad** = Fomentan y facilitan la inclusión social (aunque entornos menos predecibles)
- **Salud preventiva** (Enfoque proactivo):
  - Cuidado visión,
  - Nutrición,
  - Estilo de vida,
  - Prevención de accidentes,
  - Seguridad en el hogar,
  - Cuidados dentales,
  - Cuidados de pedicura,
  - Sexualidad (¿consejo genético, planificación familiar, homosexualidad?)
  - Revisión ginecológica.
  - …



PISTAS E IDEAS

¿Cuándo acudir?

Atención primaria.

A. **El problema.**
B. **Tolerancia a revisiones.**
C. **¿Qué necesitan del entorno?**
D. **¿Qué necesitan del profesional?**
E. **¿Qué necesitan de los acompañantes?**
F. **Conductas desafiantes.**

El hospital.

A. **Como visitantes.**
B. **Consultas médicas.**
C. **Emergencias.**
D. **Pruebas.**
E. **Cirugía.**
F. **Tratamiento médico.**
G. **Medicación.**
H. **El dentista o el óptico**

¿CUÁNDO ACUDIR?

En personas con dificultades de comunicación, cuidadores atentos a:

- Diferencias en su comportamiento y rutinas.
- Signos de malestar (llanto, gritos …)
- Agitación inexplicable.
- Incremento de rituales.
- "Tocarse/golpearse" el lugar del dolor.



Dificultades: umbral dolor, persona con historial de autolesiones, diferentes muestras de disconfort, altos niveles de ansiedad.

PISTAS E IDEAS

Atención primaria.

A. **El problema.**
B. **Tolerancia a revisiones.**
C. **¿Qué necesitan del entorno?**
D. **¿Qué necesitan del profesional?**
E. **¿Qué necesitan de los acompañantes?**
F. **Conductas desafiantes.**

ATENCIÓN PRIMARIA
A. EL PROBLEMA



- Entorno extraño y amenazador.
- Acercamiento no preparado.
- Historial de experiencias desagradables y asociación con estímulos: (ej. bata blanca). Incremento de ansiedad, pánico y miedo. Fobia a entornos o a estímulos similares.
- Rechazo al contacto físico. Percepción de ataque o amenaza.

ATENCIÓN PRIMARIA
B. INTERVENCIÓN

- Necesidad de explicación previa adaptada, de aproximaciones sucesivas, no amenazadoras…
- Simulacros y ensayos. **PROTOCOLO.**
- Estrategias básicas:
  - Proporcionar entorno seguro.
  - Atención especial a problemas sensoriales.
  - Mantener un claro sentido de estructura.
  - Considerar historia y circunstancias familiares.



ATENCIÓN PRIMARIA
C. TOLERANCIA A REVISIONES MÉDICAS

Simulacro

Trabajo en/con el Centro de Salud.

- Visitas previas al centro, aguardar su turno en sala de espera, acceder a consulta (desensibilización).
- Documentación.
- Familiarización.
- Videos.

Actividades en los Centros / Servicios/ Casa.

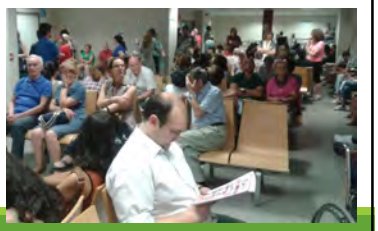
- Auscultar, depresores, extracciones, etc…



ATENCIÓN PRIMARIA
C. ¿QUÉ NECESITAN DEL ENTORNO?

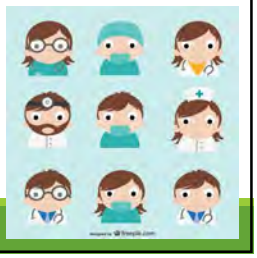
- **Lugar apartado o tranquilo**. No ruidoso, no rodeado de estrés (percepción de ambiente tenso, Hipersensibilidad, sobreestimulación: sonidos, luces, olores).
- **Recepción**: Evitar tocarle (dar la mano) y explicarle claramente cualquier contacto físico.
- Ideal:
  - Habitación sencilla.
  - Espacio silencioso.
  - Colores neutros.
  - Escasa estimulación visual.





ATENCIÓN PRIMARIA
D. ¿QUÉ NECESITAN DEL PROFESIONAL?

- Preparar la vista con antelación: Recibir información sobre las características del usuario/a.
- Adaptar tiempos y entornos de espera en la consulta.
- Ser sensible a las demandas de los acompañantes.
- Anticipar intenciones (y pasos) Ej. qué voy a hacer ahora.
- Distancia física NO INVASIVA. Evitar movimientos bruscos y rápidos
- Evitar acercamientos llenos de instrumental.
- Mantener la calma.
- Tratar de terminar la consulta de forma positiva.



Adaptaciones

De la comunicación

- Adaptar el nivel de la explicación, hacerlo por escrito.
- Evitar frases con doble sentido. Hablar claramente.
- Frases sencillas y preguntas cerradas.
- Pausas frecuentes.
- Movimientos lentos y suaves.



Uso de ayudas visuales o sistema de comunicación del cliente.

ATENCIÓN PRIMARIA
E. ¿QUÉ NECESITAN DE LOS ACOMPAÑANTES?

- Informar previamente al usuario/a del proceso.
- Informar previamente al personal sanitario de las características del usuario/a (nivel de comunicación, rutinas, problemas de conducta, etc.)
- Ensayar la secuencia habitual y presentarla.
- En consulta = Facilitar la presencia de conocidos (familiares, personas de confianza).
- Llevar actividades favoritas para la situación de espera.
- Organizar una actividad favorita a la salida.



Ejemplo 1: visita al médico







Qué pasa en la visita?

Recordar que no existen riesgos en la visita. Se debe tratar de hacer de un modo relajado (incluso lúdico).

En primer lugar se solicita la historia clínica, e informes previos, incluyendo preferencias y estilos de interacción. Información que puede resultar de interés:

- Informes de los hitos del desarrollo.
- Informes de profesores / profesionales anteriores y actuales.
- Informes médicos y psicológicos.
- Conductas desafiantes:
  - Grabación en vídeo.
  - Estrategias útiles de afrontamiento.

Proporcionar información de las pruebas a realizar: Auscultar, palpar, tomar la tensión, exploración de la boca, pruebas de coordinación, fuerza, reflejos, etc.

Después se deriva a pruebas y diagnósticos posteriores; y, lo más importante, un plan para solucionar el problema.

ATENCIÓN PRIMARIA
F. CONDUCTAS DESAFIANTES.

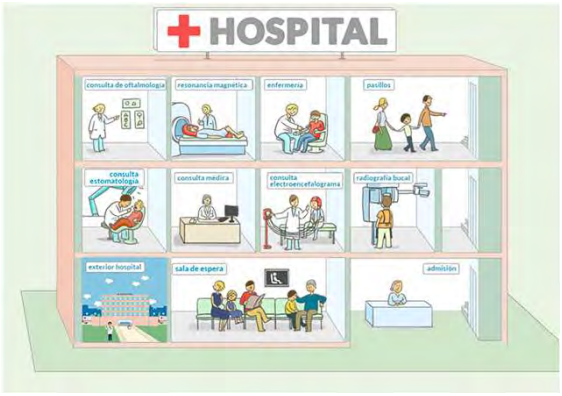


Si aparecen problemas:

- Mantenerse en calma y controlado.
- Bajar el volumen de la voz.
- No gritar ni asustar a la persona (ni permitir a otros que lo hagan).
- Si es posible, introducir algún elemento distractorio.
- Utilizar algún objeto o interés especial de la persona para restaurar la calma.

Especial cuidado en:

- Que vaya acompañado de alguien que realmente le conozca.
- Adecuada información y consentimiento sobre sedación.
- Adecuado (y legal) uso de técnicas de contención mecánica.



PISTAS E IDEAS

El hospital.

A. **Como visitantes.**
B. **Consultas médicas.**
C. **Emergencias.**
D. **Pruebas.**
E. **Cirugía.**
F. **Tratamiento médico.**
G. **Medicación.**
H. **El dentista o el óptico**

El hospital
a. Como visitantes

Entorno confuso, sobreestimulación.

- Prepararle previamente para luces, sonidos y olores inesperados.

Normas: restricciones de tiempo visitas = Rigidez. Respeto a otros pacientes.

- Acompañado.

Importante; sentimientos hacia personas cercanas.

- Observar indicadores de malestar/agitación… y preparar alternativa según nivel. Guías: stress/ relajación.

El hospital
b. Consultas médicas

- Preparar la visita previamente (CUIDADO CON CONFIDENCIALIDAD).
- Acompañado por persona cercana: familiares /tutores.
- Explicar al profesional médico quién acompaña y responsable legal.



El hospital
b. Consultas médicas

Con la pna con TEA.

- Explicar necesidad de la cita y cambios en la rutina.
- Organizar la espera.
- Preparación de la consulta en sí.
- Asegurar consentimiento (pna. TEA/tutor legal).
- Planificar alternativa si ansiedad.
- Programar necesidades futuras al acabar la visita.

Con el profesional médico:

- Adaptaciones al perfil sensorial.
- Cita cuando consulta vacía.
- Explicar quién es y qué va a hacerle.
- Usar intereses especiales.
- Asegurarse de que no tiene hambre o está cansado.

El hospital
c. Urgencias

Accidentes, envenenamiento, enfermedad aguda...

- Necesaria interpretación/acompañamiento de familiares/tutores.
- Buscar lugar tranquilo y solitario.
- Probablemente está alterado y a la defensiva.
- NUNCA dejarlo sólo o inatendido.
- Mínimo contacto físico: solo el necesario.
- Lenguaje sencillo y claro, voz baja.
- Cuidado con contacto ocular (intimidatorio).
- Respetar confidencialidad.





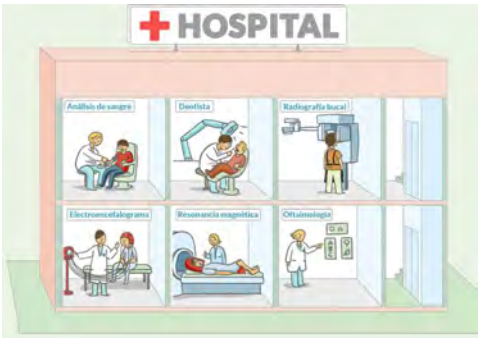
El hospital
c. Urgencias

- Si tiene que ingresar: Explicar particularidades BIEN y a TODOS.

  Avisar de:
  - Alimentación: dietas, intolerancias, hábitos peculiares, etc.
  - Aseo personal: capacidades, rutinas y hábitos (algunos apoyo absoluto).
  - Falta de inhibición. No idea privacidad (puestas aseo abiertas, ropa sin abrochar).
  - Aseo dental, cuidado del cabello, menstruación…
- Si es posible ejercicios relajación.
- Posible reacción defensiva (alto nivel). Aclara pruebas y cuidado interpretación literal: “sacar sangre”, “dame el brazo”.
- Ingreso inconsciente: ¿qué pasará al despertar? Desorientado y alarmado. Reacción imprevisible > supervisión constante.

El hospital d. Pruebas

- Planificar, anticipar y acompañar en las diferentes fases.
- Ambiente con mínima estimulación y distracción.
- Mínimo contacto físico.
- Instrucciones directamente observables por imitación (cuando sea posible). Ej. Para los rayos X “respira así.. Ahora ¡para!”
- Evitar “infantilizar” el trato con personas adultas aunque no comprendan la situación.



www.doctortea.org/entra/pruebas/

www.doctortea.org/comunidades/comunidad-de-madrid/hospital-gregorio-maranon/pruebas/analisis-de-sangre-2/



Ejemplo: Exploración ginecológica

- **Conocer en qué consiste un examen ginecológico/ urológico.**
- **Información sobre cuándo acudir.**
- **Preparación previa a la consulta.**
  - **Usuarios.**
  - **Profesional sanitario.**











El hospital e. Cirugía

Literatura específica sobre protocolos de anestesia:

- Importante contar con suficiente información previa.
- Posibilidad anestesiar en habitación contigua.
- Tiempo de espera muy corto.
- Si pernocta alojamiento familiares cerca.
- Administración de sedantes preoperatorios orales con bebida favorita, etc.…



Ejemplo 1: Anestesia

Es posible que sea necesario sedar al paciente para ciertos procedimientos. En ese caso:

- No dar ningún alimento ni líquido 3 ó 4 horas antes de la anestesia.
- Si está enfermo, avisar y comprobar antes de la anestesia.
- Traer al paciente cansado a la prueba (es más fácil dormir si ya está cansado. No permitir el sueño en el transporte hacia la prueba.
- La anestesia para pruebas, debe aplicarse en el mismo sitio que se realice la prueba.



El hospital
f. Tratamiento médico

CUIDADOS INTENSIVOS:

- Prestar especial apoyo a la familia. Cómo dar información a las familias:
  - Considerar:
    - Cuándo dar la información.
    - Cuánta información dar.
    - Qué temas específicos tratar.
    - Cómo conseguir que el mensaje sea efectivo.
  - Formatos:
    - Verbal / escrita/ vídeo / formatos electrónicos-multimedia e internet / Juegos o role-play.
  - Contenidos:
    - Utilizar preguntas abiertas que animen a los pacientes hablar.
    - Limitar la cantidad de información que se da de una vez.
    - Utilizar refuerzos, como información escrita.
    - Centrarse en los temas importantes.
    - Comprobar que se entiende el mensaje – por ejemplo, pedirle al paciente que repita los mensajes clave en sus propias palabras.
    - Comprobar la retención de información del paciente en citas posteriores u revisando el material cuando sea necesario.



Caress AL (2003) Giving information to patients. *Nursing Standard*. 17, 43, 47-54.

El hospital
f. Tratamiento médico

Consentimiento:

- Proceso admisión en hospital: ¿Qué es?¿qué me llevo?¿qué me van a hacer?
- Consentimiento:¿Qué es el consentimiento?¿Qué información me deben dar sobre el tratamiento?¿quién puede dar consentimiento?¿qué significa capacidad?¿puedo ser forzado a aceptar un tratamiento?
- Hospitalización: Vida en el hospital (medicación, alimentación, noches, privacidad, seguridad…).
- No dar por hecho que: no expresar signifique no comprender. Dar información adaptada a las capacidades y esperar aprobación a su nivel. Necesitaremos además su colaboración.
- Imprescindible contar también con colaboración de cuidadores y familiares.

El hospital
f. Medicación

Medicación:

- Especial cuidado con el control de la medicación.
- Escoger formato y forma presentación más adecuada: Liquido /pastillas / con alimentos...
- Responsable administración medicación claramente identificado y autorizado. Información permanente de cambios.
- Medicación inyectable: Extremar precauciones, ofrecer pequeñas recompensas al terminar.
- Efectos secundarios: no saben explicarlos, hay que observar.

« El buen uso de los fármacos ha cambiado mi vida»

(Temple Grandin, 1986)



Decálogo prescripción medicación

No … medicamentos “para el autismo”.
Sí … fármacos para ciertos “problemas”.
No … porque no haya avances.
Sí … como complemento de otras acciones.
No … sustituto de otras intervenciones.
Sí … como prueba temporal.
No … sin descartar problemas físicos.
Sí … seguir las pautas de administración.
No … ignorar los efectos secundarios.
Sí … implicar a los consumidores.



Pharmautisme

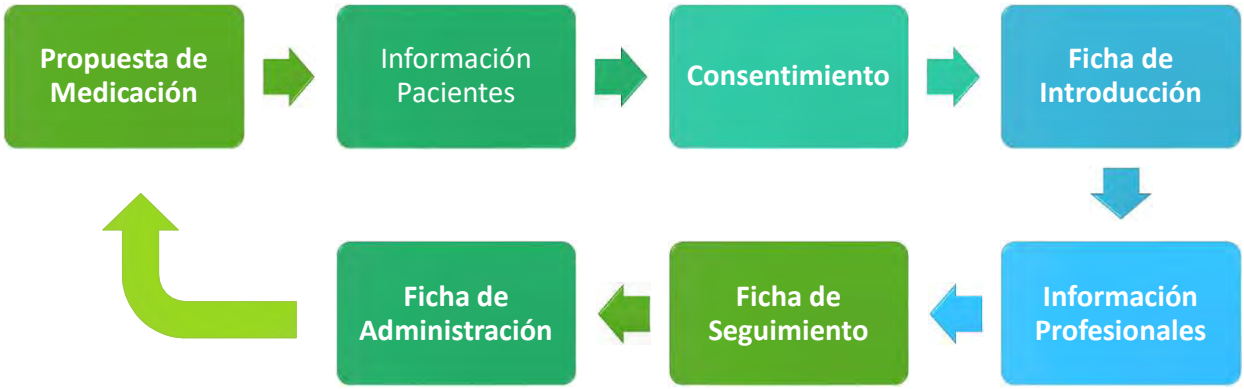
Sistema Protocolizado de Tratamiento Psicomarcológico en Personas con Autismo y otros Trastornos del Desarrollo

- **Joaquín Fuentes**
- **Mariví Cundin**
- **Ignacio Gallano**
- **José Luís Gutiérrez**



www.pharmautisme.org

Pharmautisme

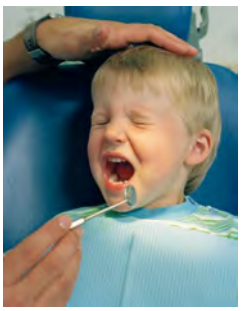




El hospital g. el dentista

Dentista = sobreestimulación: luz brillante en la cara, ruido del taladro, instrumentos fríos en la boca, sabor fuerte del enjuague o pasta… posibilidad de conductas desafiantes, podemos tomar una serie de medidas:

- Planificar visita informal antes del tratamiento. Conocer al profesional, instalaciones y equipo, ej. silla dentista, luces, gafas...
- Permitir al niño ver como se trata a otra persona, por ejemplo su hermano/a.
- Se puede "tratar" a una muñeca, ej. revisión visual rápida, prueba dental...
- Idea: reservar doble cita para ajustar los tiempos a las necesidades del paciente.



Recursos:



IR AL MÉDICO. Una guía para niños con Trastornos del Espectro Autista



IR AL DENTISTA. Una guía para personas con autismo y síndrome de asperger



LAS PERSONAS CON AUTISMO EN EL ÁMBITO SANITARIO



Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria



Comorbilidades médicas en los trastornos del espectro autista. Manual básico para el personal de atención de salud y formuladores de políticas



Guía de actuación en Urgencias para personas con autismo



Guía de intervención ante los trastornos de la alimentación en niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)



Cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente

5. BIBLIOGRAFÍA



Barthélemy C., Fuentes J., Van der Gaag R., Visconti P., Shattock P. (2000) *Descripción del Autismo.* Documento oficial de la Asociación Internacional Autismo-Europa. Autisme-Europe. Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://iier.isciii.es/autismo/pdf/aut_autis.pdf

Grupo de Estudio de Trastornos del Espectro Autista (2004).*Preguntas más frecuentes*. Instituto de Investigación de Enfermedades Raras- Instituto de Salud Carlos III. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.isciii.es/htdocs/centros/enfermedadesraras/autismo/autismo_preguntasfrecuentes.jsp

Grupo de trabajo (2000). *La persona con autismo y sus necesidades. Programas y recursos*. Jornadas internacionales. Burgos, (Abril, 2.001)

California health and human services agency (2003). *Autistic spectrum disorders: Changes In The California Caseload An Update: 1999 Through 2002.* Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://www.dds.ca.gov/autism/pdf/AutismReport2003.pdf

Medical Research Council : *REVIEW OF AUTISM RESEARCH; Epidemiology and causes.* Diciembre, 2001 http://www.mrc.ac.uk/pdf-autism-report.pdf

Belinchón, M. (2001) (coord.). *Situación y necesidades de las personas con trastornos del espectro autista en la Comunidad de Madrid.* Madrid: Ed. M & M. - se puede adquirir gratuitamente en la librería Paradox. Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://iier.isciii.es/autismo/pdf/aut_autmad.pdf

Diez Cuervo et al., 1987: http://www.autismo.com/scripts/articulo/smuestra.idc?n=a2

Tuchman R.F., Moshé S.L., Rapin I..(2005) *Trastornos del neurodesarrollo y epilepsia* Revista de neurología Vol.40 Num. S01 Pág. S003 Fecha de publicación: 15/01/2005. http://www.revneurol.com/

Muñoz Yunta J.A., Salvadó Salvadó B., Ortiz Alonso T., Amo Usanos C., Fernández Lucas A., Maestú Unturbe F., Palau Baduell M.. *Clínica de la epilepsia en los trastornos del espectro autista.* Rev Neurol Vol.36 Num.s1 Pág.0061 Fecha de publicación: 20/02/2003. http://www.revneurol.com/

Atwood, T. (1998). Asperger's Syndrome: A guide for parents and Professionals. London: Jessica Kinsley Publishers.

Autism Task Force. *Service guidelines for individuals with autism spectrum disorder/pervasive developmental disorder (ASD/PDD) Ages birth through twenty-one.* Ohio Department of Health. Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://ddc.ohio.gov/Pub/ASDGuide.PDF

Smith Myles, B., Tapscott Cook, K., Miller, N.E., Rinner, L. and Robbins, L.A. (2000), *Asperger Syndrome and Sensory Issues: practical solutions for making sense of the world.* Shawnee Mission, KS : Autism Asperger Publishing.

Jordan R., Jones G. y Morgan H., (2001). *A Guide to Services for Children with Autistic Spectrum Disorders for Commissioners and Providers.* Foundation for People with Learning Disabilities. Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://www.learningdisabilities.org.uk/page.cfm?pageurl=reports.cfm

5. BIBLIOGRAFÍA



- Foundation for People with Learning Disabilities (2004.). *Green Light Toolkit - How good are your mental health services for people with learning disabilities? a service improvement toolkit.* Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople146.jsp
- NHS Quality Improvement Scotland (NHS QIS) (2004) *Quality Indicators for Learning Disabilities*. NHS Quality Improvement Scotland y People First Scotland. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.nhshealthquality.org/nhsqis/files/Learning%20Disability%20Quality%20Indicators.pdf
- Morton Cooper A. (2004). *Health care and the autism spectrum, a guide for health professional, parents and carers*. Jessica Kingsley publishers.
- Baron-Cohen, S. (1997). *Mindblindness: An essay on Autism and Theory of mind*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Departamento de Profilaxis, Odontopediatría y Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y Asociación para la investigación y el estudio de la Deficiencia Mental CEPRI.(1998). *Protocolo de calidad de la atención bucodental a niños y niñas con autismo*.
- Autism Steering Committee, North Shore-LIJ Health System (2004). *Your Next Patient Has Autism…* Obtenido 6 noviembre, 2006 en: www.northshorelij.com/autism
- Valuing People: A New Strategy for Learning Disability for the 21st Century (2002). *Guidance for Restrictive Physical Interventions How to provide safe services for people with Learning Disabilities and Autistic Spectrum Disorde.* Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/06/84/61/04068461.pdf
- Department for education and skills. Darlington. *Guidance on the Use of Restrictive Physical Interventions for Staff Working with Children and Adults who Display Extreme Behaviour in Association with Learning Disability and/or Autistic Spectrum Disorders.* Department of health. Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://www.teachernet.gov.uk/_doc/6059/PI%20Guidance.pdf.
- Gloucestershire Partnership NHS Trust. *Traffic Light Hospital Assessment. Hospital assessment for people with learning disabilities.* Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople145.jsp
- Illera A. (2004) *La gestión del Duelo en Personas con Autismo*. Actas de XII Congreso Nacional de profesionales del autismo AETAPI.
- Better Health through Better Communication – NHS Lothian/Scottish Ambulance Service. *Going in an ambulance in an emergency.* http://www.nhshealthquality.org/nhsqis/files/going_in_an_ambulance.pdf
- Van Der Walt J.H., Moran C. (2001) *An audit of perioperative management of autistic children.* Paediatr Anaesth 2001 Jul;11(4):401-8
- Rainey L, van der Walt JH.(1998) *The anaesthetic management of autistic children*. Anaesth Intensive Care 1998 Dec;26(6):682-6
- Allison KP, Smith G.(1998) Burn management in a patient with autism. Burns 1998 Aug;24(5):484-6
- Braff MH, Nealon L. *Sedation of the autistic patient for dental procedures*. ASDC J Dent Child 1979 Sep-Oct;46(5):404-7

5. BIBLIOGRAFÍA



- Davies R. (2004) *Consent to medical treatment*. Mind Rights Guide nº 3. Mind (National Association for Mental Health). London. Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://www.mind.org.uk/Information/Booklets/Rights+guide/RG3.htm
- Campbell P. (2003) *How to… cope with hospital admission.* Mind (National Association for Mental Health). Obtenido 6 noviembre, 2006 en: http://www.mind.org.uk/NR/rdonlyres/F3317147-E893-4F8C-9B20-27EC58A5E539/0/copewithhospital.pdf
- The Learning Disability Partnership Board in Surrey. *The Hospital Communication Book. Helping to make sure people who have difficulties understanding and/or communicating get an equal service in hospital.* Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople145.jsp
- Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III .*Guía de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista.* Ministerio de Sanidad y Consumo, España), Revista de Neurología, 2006; 43 (7): 425-438. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.revneurol.com/
- Fuentes J, Cundin M, Gallano I, Gutiérrez JL. Pharmautisme: sistema protocolizado de tratamiento psicofarmacológico en personas con autismo y otros trastornos del desarrollo. Burgos: Confederación Autismo España; 2001.
- Adult Learning Disability Division (Health) (2006) *When you have teeth out.* Mytton Oak. NHS, Shropshire County Primary Care Trust. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.shropshirepct.nhs.uk/
- NHS Foundation Trust. *Welcome to the Eye Department at the Royal Hallamshire Hospital.* Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople145.jsp
- Caress A-L., (2003) Giving information to patients. *Nursing Standard.* 17, 43, 47-54. Date of acceptance: May 21 2003.
- Valuing People: A New Strategy for Learning . Disability for the 21st Century. *Health Action Plans and Health Facilitation , Good Practice Guidance for Learning Disabilities Partnership Boards* (Easier to read version – reference no 28602) . *Health Action Plans, What are they? How do you get one (booklet for People with Learning Disabilities* – reference no 28599) *Health Action Plans, What are they? How do you get one* (booklet for People with Learning Disabilities – reference no 28612) Department of Health Publications. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople142.jsp
- Valuing People Support team. *Example of the Health Action Plan*. CSIP. Care Services Improvement Partnership. Foundation for People with Learning Disabilities. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople143.jsp
- The disability team y Mark Mayes (Self advocate) *Keeping Healthy, My Health Plan.* Peterborough Partnership. Valuing People Support team. CSIP. Care Services Improvement Partnership. Foundation for People with Learning Disabilities. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople143.jsp
- Valuing People Support team. *Going to the Doctor. A leaflet for people with learning disabilities.* CSIP. Care Services Improvement Partnership. Foundation for People with Learning Disabilities. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople143.jsp

5. BIBLIOGRAFÍA



- Valuing People Support team. *My health choices. opportunities + dreams. A presentation to use with people with learning disabilities.* CSIP. Care Services Improvement Partnership. Foundation for People with Learning Disabilities. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople143.jsp
- McIntosh B., Co-Director. Valuing People Support team. *Personal Planning Book. Example of personal plan. Learning Disability Programme*. The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health Foundation, London. CSIP. Care Services Improvement Partnership. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople143.jsp.
- NHS Quality Improvement Scotland (NHS QIS) (2006). *Promoting access to healthcare for people with a learning disability – a guide for frontline NHS staff.* Best Practice Statement. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.nhshealthquality.org/nhsqis/files/BPS%20Learning%20disabilities%20(Feb%202006).pdf
- Lindsey M. y Russell, O. (1999) *Once a Day, one or more people with learning disabilities are likely to be in contact with your primary healthcare team. How can you help them?* Good practice. Department of Health. Wetherby. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople144.jsp
- Adult Learning Disability Division (Health) (2006). *The Pain is in my……?* Mytton Oak.. NHS, Shropshire County Primary Care Trust. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.shropshirepct.nhs.uk/
- Phlebotomy Service Royal Shrewsbury Hospital North. Adult Learning Disability Division (Health) (2006). *A visit for a Blood Test At the Royal Shrewsbury Hospital.* Mytton Oak. NHS, Shropshire County Primary Care Trust. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.shropshirepct.nhs.uk/
- Adult Learning Disability Division (Health) (2006). *Consent A guide for adults with learning dificulties* Mytton Oak. April 2006. NHS, Shropshire County Primary Care Trust. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.shropshirepct.nhs.uk/.
- Adult Learning Disability Division (Health) (2006) *A Visit to the Pre-assessment Unit at The Princess Royal Hospital Telford.* Mytton Oak. NHS, Shropshire County Primary Care Trust. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.shropshirepct.nhs.uk/
- Adult Learning Disability Division (Health) (2006) *A Visit to Pre-assessment At The Royal Shrewsbury Hospital.* Mytton Oak. April 2006. NHS, Shropshire County Primary Care Trust. http://www.shropshirepct.nhs.uk/.
- Adult Learning Disability Division (Health) (2006) Going into Hospital for a CT Scan.Mytton Oak. NHS, Shropshire County Primary Care Trust. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://www.shropshirepct.nhs.uk/
- Valuing People Support team. CSIP. *Example of an invitation to go to a practice from Westwood Clinic.* Care Services Improvement Partnership. Foundation for People with Learning Disabilities. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople143.jsp
- *National Patient Safety Agency* (2005). *Getting to know your pharmacis'.* Eastbrook Centre, Gloucester. 2005. Obtenido 6 noviembre, 2006: http://valuingpeople.gov.uk/dynamic/valuingpeople118.jsp

Preguntas ?

Personas con autismo en la Sanidad Pública Andaluza

Federación Autismo Andalucía

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo



¡GRACIAS!

Creemos en las personas

¡¡Muchas gracias!!